

Masterclass Profesional:

Psicodiagnóstico para Porte y Tenencia de Armas

Dirigido a psicólogos que deseen formarse en la evaluación integral de sujetos con solicitud de porte y/o tenencia de armas.

 **Fecha:** Sábado 26 de julio

 **Horario:** 9:00 a 12:00 hs (hora Uruguay)

 **Modalidad:** Online en vivo por Google Meet

 **Incluye certificado, materiales PDF y bibliografía técnica**

Objetivo General

Capacitar a psicólogos en el abordaje pericial y clínico del psicodiagnóstico exigido para la portación y tenencia de armas de fuego, con enfoque técnico, ético, legal y proyectivo.

1. Marco Ético, Legal y Profesional

- Fundamento legal y normativo en Uruguay: porte vs. tenencia.
 - **El rol del psicólogo como garante de la seguridad pública.**
 - Responsabilidad ética: consentimiento informado, confidencialidad y decisiones clínicas.
 - Evaluación con finalidad civil, policial o institucional.
-

2. Entrevista Clínica y Análisis de Riesgo

- Guía de entrevista estructurada para evaluación de porte y tenencia.
 - Exploración de:
 - Historia clínica y antecedentes psiquiátricos.
 - Consumo de sustancias.
 - Ideación suicida, episodios de desregulación emocional.
 - Conductas agresivas actuales o pasadas.
 - Motivación para portar un arma.
 - **Factores de riesgo:** impulsividad, violencia, trastornos de personalidad, disociación.
 - **Factores protectores:** red de apoyo, estabilidad laboral, autoconciencia emocional.
-

3. Técnicas Psicológicas: Aplicación e Interpretación

PBILL (Persona Bajo la Lluvia - adaptación forense)

- Evaluación de recursos de afrontamiento, percepción de amenazas, vulnerabilidad psíquica.
- Indicadores: desorganización, retraimiento, necesidad de protección externa, fragilidad yoica.

HTP (Casa-Árbol-Persona)

- Acceso a contenidos inconscientes y proyecciones del self.
- Indicadores de control de impulsos, vínculos familiares, agresividad latente y estructura de personalidad.

BENDER Visual Motor Gestalt Test

- Detección de indicadores neurológicos, desorganización perceptual, impulsividad y deterioro cognitivo.
- Ítems clave: inversión, perseveración, omisión, segmentación.

Figura Humana (Machover)

- Evaluación de la autoimagen, estructura del yo, impulsividad y mecanismos defensivos.
- Indicadores clave:
 - Trazos fuertes o débiles → control impulsivo vs. inhibición.
 - Omisión de partes → disociación, negación, organicidad.
 - Tamaño y ubicación → autoestima, desorganización, nivel madurativo.

4. Integración Diagnóstica y Redacción del Informe

- Criterios de integración clínica: ¿es Apto? ¿Apto con reservas? ¿No Apto?
- Redacción de informes claros, técnicos y éticamente fundamentados.
- Ejemplo de informe real (anónimo) con estructura profesional:
 - Datos de filiación
 - Motivo de consulta
 - Técnicas aplicadas
 - Resultados
 - Conclusión diagnóstica
 - Dictamen psicológico

Primeras consideraciones

El psicólogo, en su rol de evaluador de porte y tenencia de armas, actúa como una bisagra entre la salud mental individual y la seguridad colectiva. La calidad, profundidad y ética de su trabajo pueden salvar vidas.

1. MARCO ÉTICO, LEGAL Y PROFESIONAL

1.1. Fundamento legal y normativo en Uruguay: porte vs. tenencia

En Uruguay, la **tenencia y porte de armas de fuego** está regulada por el **Decreto-Ley N° 10.415** (1943), **Ley N° 19.247** (de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados), sus decretos reglamentarios, y por normas internas del **Ministerio del Interior**, la **Dirección Nacional de Policía Científica** y **Jefaturas Departamentales**.

★ Diferencia legal:

- **Tenencia de arma:** Derecho a **poseer un arma** en un **lugar determinado** (ej: hogar, empresa, chacra). Requiere autorización, inscripción y evaluación de aptitud.
- **Porte de arma:** Autorización **especial** para llevar consigo el arma **en lugares públicos** o de libre circulación. **Implica requisitos más exigentes, ya que presupone uso inmediato o eventual del arma en situaciones de tensión o amenaza.**

Requisitos generales (según Ley 19.247 y Decreto 377/016):

- Ser mayor de 18 años.
- No poseer antecedentes penales ni policiales.
- Superar evaluaciones técnicas y psicológicas.
- Declaración jurada de domicilio y actividad laboral.
- No presentar antecedentes de consumo problemático de sustancias.
- Presentar **certificado de aptitud psicológica emitido por profesional habilitado**.

⚠ El psicólogo tiene la función clave de certificar si la persona evaluada reúne condiciones psicológicas compatibles con el manejo responsable de un arma.

Este enfoque permitirá que los psicólogos asistentes comprendan el **contexto legal-administrativo** de su rol, y cómo la evaluación que realizan se **vincula directamente con el Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas (THATA)**.

¿Qué es el THATA?

THATA significa:

Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas

Es un documento **oficial, emitido por el Ministerio del Interior**, que habilita legalmente a una persona a **adquirir, registrar y conservar un arma de fuego en su domicilio o entorno privado**.

★ ¿Dónde debe estar registrado un psicólogo para emitir el certificado psicológico del THATA?

1. Registro del Ministerio de Salud Pública (MSP)

Todo/a psicólogo/a que ejerza en Uruguay debe estar inscrito/a en el Registro de Profesionales de la Salud del MSP, tras presentar el título académico (Licenciatura en Psicología) o equivalencia legal. Esta inscripción lo habilita formalmente para ejercer la profesión en todo el territorio nacional

2. Registro ante DI.GE.F.E. (Dirección General de Funcionamiento y Evaluaciones)

Para poder realizar evaluaciones psicotécnicas con fines legales (como el THATA y el porte de armas), el profesional debe estar habilitado en los registros institucionales del Ministerio del Interior, específicamente registrado ante la DI.GE.F.E., que es la unidad responsable de llevar el control y emisión de certificados psicotécnicos en el marco del trámite THATA.

En resumen:

Requisito	Institución	Propósito
Título habilitante en Psicología	Ministerio de Salud Pública (MSP)	Registro profesional obligatorio
Registro para evaluaciones THATA	DI.GE.F.E. / Ministerio del Interior	Registro en base de datos oficial para THATA

¿Por qué son necesarios estos registros?

El registro en MSP garantiza que el profesional cuenta con la formación académica y la habilitación formal para ejercer.

- **El registro en DI.GE.F.E. asegura que el psicólogo esté autorizado específicamente para actuar como evaluador en trámites normados por el Ministerio del Interior, como el THATA o el Porte de Armas**

¿Qué establece la Ley?

De acuerdo con la **Ley N.º 19.247** y su decreto reglamentario (N.º 377/016), **toda persona que desee adquirir o tener un arma de fuego debe tramitar primero el THATA.**

Para ello, el solicitante debe presentar:

- Certificado de **aptitud psicológica** (emitido por un psicólogo habilitado).
- Certificado médico general.
- Comprobante de ingresos.
- Certificado de antecedentes penales.
- Curso habilitante (desde 2021 para nuevos solicitantes).
- Documentación del arma y lugar de tenencia.

👉 El THATA **no habilita automáticamente el porte del arma en la vía pública, pero es un requisito obligatorio** para luego tramitar ese permiso.

¿Cuál es el rol del psicólogo en el proceso del THATA?

El profesional evaluador debe:

1. **Emitir un certificado de aptitud psicológica**, basado en una evaluación estructurada, técnica y ética.
2. Detectar posibles **indicadores de riesgo psíquico, emocional o conductual** que contraindiquen la tenencia.
3. **Actuar como operador de prevención, protección social y garante de seguridad pública.**

La evaluación psicológica es la única instancia del THATA que permite anticipar si el solicitante tiene capacidad para manejar el poder simbólico y real de un arma.

- ✓ **Sitúa legalmente al evaluador.**
- ✓ **Ordena el encuadre clínico y técnico.**
- ✓ **Brinda un marco institucional al informe.**
- ✓ **Refuerza la función preventiva del psicólogo.**

¿Puede un civil PORTAR un arma según la ley uruguaya?

✓ **Tenencia y porte: diferencias básicas**

- **Tenencia de armas (THATA):** Cualquier persona mayor de 18 años puede tramitar el **Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas (THATA)** para poseer hasta 8 armas. Se requiere certificado psiquiátrico, antecedentes judiciales, certificado físico, constancia de ingresos y, para nuevos solicitantes, curso habilitante
 - **Porte de armas (permiso adicional):** Para llevar un arma de fuego a plena disposición en espacios públicos, se requiere solicitar un **permiso específico de porte**, además del THATA
-

🔪 Quiénes pueden portar armas

El porte **no es un derecho general**: se concede en casos justificados y con evaluación oficial:

- Autoridades políticas como ministros, legisladores, fiscales, jueces, miembros de la Suprema Corte, durante su mandato
 - **Personal de seguridad privada habilitado**, tras completar curso, certificaciones laborales y psicológicas.
 - Policías y militares, **retirados o en actividad**, sin antecedentes, con evaluación psicofísica, con renovación cada 5 años
 - **En la práctica**, el porte se otorga **en forma discrecional**, generalmente a guardias privados y retirados. La autorización a civiles comunes es **muy poco frecuente**, exige demostrar motivos reales como riesgo personal concreto
-

Requisitos específicos para civiles

1. **Tener THATA válido** (tenencia acreditada).
2. **Solicitar permiso de porte** en la Jefatura de Policía (según Decreto 345/020).
3. Presentar documentación: antecedentes judiciales, certificado de aptitud psicológica, ingresos, guía del arma, curso de manejo y cursos habilitantes
4. **Justificación probada de necesidad (seguridad personal o laboral), evaluada a criterio policial.**
5. Renovación periódica del porte (cada 3-5 años según normativa vigente).

⚠ Consideraciones para el psicólogo clínico-forense

- La norma exige **certificado de aptitud psicológica** como paso previo a toda habilitación
- El profesional evalúa si el solicitante es **psíquicamente apto para poseer/desplazar un arma** en su entorno cotidiano.
- El permiso de porte es discrecional y **depende no solo del informe técnico, sino del juicio institucional sobre el riesgo percibido.**
- **La evaluación del psicólogo es esencial y vinculante: puede habilitar o impedir la obtención del porte.**

Resumen

Aspecto	Civil particular
Tenencia de arma	Permitida tras THATA
Porte de arma	Excepcional, mediante permiso específico
Requisitos psicológicos	Obligatorio para ambos
Evaluación de seguridad	Requiere justificación real
Práctica habitual	Solo guardias, civiles en casos muy puntuales

Sí: un civil puede portar un arma en Uruguay, pero bajo condiciones excepcionales, con autorización específica basada en un THATA válido, evaluación psicológica y aprobación institucional. La norma y el decreto establecen este proceso de manera rigurosa.

Sin permiso de porte, almacenar un arma en espacios públicos o transportarla cargada está **penalizado**, incluso si se posee THATA

Evolución legislativa en materia de control de armas de fuego

En la legislación uruguaya se encuentran seis delitos referidos a la posesión, el porte y el tráfico ilegal de armas de fuego. En el año 1995, a través del [artículo 15 de la Ley de Seguridad Ciudadana](#) se incorporó al Código Penal el delito de “Porte y tenencia de armas”. En el año 2001 mediante el [artículo 141 de la ley de presupuesto](#) se agregó un delito a quien porte un arma de fuego estando condenado con sentencia firme por delitos como asociación para delinquir, violación, atentado violento al pudor, entre otros, o cometiera dichos delitos con violencia o intimidación usando un arma de fuego. Finalmente, en el año 2014 mediante [la aprobación de la Ley N.º 19.247](#), se sustituyó el delito “Porte y tenencia de armas” por el de “Porte y tenencia de armas de fuego” y se agregaron los delitos de tráfico interno e internacional de armas de fuego, así como su tenencia no autorizada y porte en lugares públicos. El [decreto reglamentario N° 345/020](#) tiene el objetivo de lograr un efectivo contralor para la adquisición de armas de fuego y municiones.

La tenencia legal de armas de fuego

“En la actualidad, la compra, herencia o regularización de un arma, requiere la obtención del Título de Habilitación

de Adquisición y Tenencia de Armas (THATA) que tiene una validez de cinco años. Este título autoriza la tenencia de hasta ocho armas; quien quiera poseer más de esta cantidad deberá tramitar el carné de coleccionista. La tipificación penal de tráfico interno de armas hace que tener un arma sin el debido permiso se transforme en un delito.

Para adquirir y tener cualquier tipo de arma autorizada, el primer paso es obtener el THATA ante la Jefatura de Policía del departamento en el que se reside. El interesado debe tener 18 años cumplidos, constancia de Certificado de Antecedente Judiciales y justificativo de ingresos o medios de vida. Además, es necesario un certificado de aptitud psicofísica expedido por un profesional competente que evalúa la estabilidad emocional del solicitante. Asimismo, quien realiza el trámite por primera vez requiere un certificado de idoneidad en el manejo de las armas y de conocimientos de la legislación vigente. En los últimos diez años se han renovado y tramitado por primera vez un promedio de 6.000 THATA por año”

Luego que se adquiere el arma se debe tramitar la Guía de posesión de armas, que es el documento que acredita la propiedad de la misma. Se expide en el Registro Nacional de Armas (RNA) dependiente del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional. El RNA lleva la trazabilidad de todas las armas que ingresan al país de forma legal, hasta su destrucción. Hay unas 615.000 armas registradas oficialmente.

El THATA y la guía habilitan para tener y a transportar un arma de un lugar a otro, descargada y con la munición en una caja adecuada. Esto significa que el arma no puede estar lista para ser usada. Para portar un arma, en condiciones de ser usada de forma inmediata, es necesario tramitar el Porte de Armas. El porte se encuentra limitado a las armas cortas, no más de una a la vez y no puede estar a la vista. En los últimos tres años, los pedidos de porte de armas han aumentado, influenciado por el hecho de que la nueva reglamentación exige que los oficiales de la Policía y de las Fuerzas Armadas en situación de retiro realicen el trámite, requisito que antes no era necesario.” CRERES-A

1.2. EL ROL DEL PSICÓLOGO COMO GARANTE DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

La intervención del psicólogo en estos contextos **no es neutra ni meramente administrativa**, sino que cumple un **rol social y ético trascendental**, ya que su dictamen puede prevenir (o habilitar) **situaciones de riesgo con consecuencias irreversibles**.

✓ **Funciones esenciales del psicólogo evaluador:**

- Detectar **factores de riesgo** como **impulsividad, desorganización psíquica, consumo, inestabilidad emocional o vulnerabilidad mental**.
- Identificar **factores protectores**: **autocrítica, responsabilidad, control de impulsos, red de apoyo, estabilidad emocional**.
- Emitir un **informe técnico fundado** que permita a las autoridades policiales o civiles tomar una decisión informada sobre la aptitud del solicitante.

Evaluar es prevenir:

Cada informe psicológico en este contexto actúa como una medida preventiva de salud pública y protección social.

🔑 1.3. Responsabilidad ética: consentimiento informado, confidencialidad y decisiones clínicas

La práctica del psicólogo debe alinearse con el **Código de Ética de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay** y los principios deontológicos del ejercicio profesional.

Consentimiento informado:

- Debe explicarse **la finalidad específica** de la evaluación (no es una consulta clínica, sino una **valoración para porte o tenencia de arma**).

- Se debe informar que los **resultados pueden determinar la aprobación o rechazo del trámite.**
- Debe quedar registro de la **firma del evaluado** en consentimiento (puede estar incluido en la ficha técnica).
- **Solicitar copia de cedula de identidad**

Confidencialidad con límites:

- La confidencialidad se mantiene **dentro del marco de la evaluación**, pero:
 - **No se puede garantizar absoluta reserva**, ya que el informe se entrega a una autoridad administrativa o policial.
 - **Debe comunicarse al evaluado que el resultado será entregado a un tercero.**

Decisiones clínicas complejas:

El psicólogo puede encontrarse con situaciones clínicas no esperadas:

- Detectar un **trastorno psiquiátrico o riesgo suicida** → derivación urgente.
- Identificar un **perfil manipulador o disociativo** → **contraindicación del porte.**
- Percibir una **simulación de ajuste emocional** → se requiere profundización o contraindicación.

⚠ La ética profesional exige que la evaluación sea rigurosa, que se utilicen múltiples fuentes de información (entrevista + test), y que las decisiones estén bien fundamentadas.

1.4. Evaluación con finalidad civil, policial o institucional

La evaluación psicológica puede ser solicitada en diferentes contextos:

A. Finalidad civil:

- Solicitantes particulares que desean tener un arma por seguridad personal, legítima defensa, o para actividades deportivas.
- En este caso, el psicólogo evalúa como profesional independiente y redacta un informe que será entregado al solicitante o a la Dirección Nacional de Policía Científica.

B. Finalidad policial o militar:

- Integrantes de fuerzas armadas, policiales o penitenciarias que requieren un informe técnico.
- En estos casos, **se aplica un estándar aún más estricto**, dado que estas personas **portarán armas durante su jornada laboral y están expuestas a situaciones de riesgo**.

C. Finalidad institucional (guardias, custodias, empresas de seguridad):

- Evaluación solicitada por una empresa o institución contratante.
- El informe puede tener carácter **pericial laboral**, y el psicólogo debe estar atento a **presiones externas** que pueden intentar incidir en el resultado.

🔗 ARTICULACIÓN CON EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL PSICÓLOGO

Implicancias éticas en la evaluación psicológica para porte y tenencia de armas

◆ 1. HABILITACIÓN DEL PSICÓLOGO PARA REALIZAR ESTA EVALUACIÓN

✦ Artículo 2 – Principios Generales

“El psicólogo debe ejercer su actividad únicamente cuando esté debidamente calificado y habilitado para ello, con formación técnica suficiente...”

El psicólogo que evalúa para porte o tenencia de armas debe contar con **formación en psicodiagnóstico clínico-forense**, conocer los instrumentos aplicables, interpretar indicadores de riesgo y tener capacidad para **emitir dictámenes con peso legal**. **No basta con formación clínica general.**

❖ **Responsabilidad ética:** No aceptar solicitudes para las que no se tiene formación específica **vulnera el principio de competencia profesional y puede derivar en daños.**

◆ 2. SECRETO PROFESIONAL Y SUS LÍMITES

✦ Artículo 13 – Secreto Profesional

“El secreto profesional es un deber ético y un derecho del paciente. Se extiende a todos los datos y hechos conocidos en el ejercicio de la función...”

✦ Artículo 15 – Excepciones

“Podrá revelarse solo en caso de riesgo cierto e inminente para la vida o integridad física de terceros o del propio sujeto, o cuando se actúe como perito judicial.”

☞ **Aplicación en la evaluación por porte de armas:**

- Aunque el evaluado no sea un “paciente” clásico, el psicólogo **está obligado a respetar la confidencialidad del proceso evaluativo.**
- Sin embargo, el profesional debe advertir que el informe **no será confidencial**, ya que será entregado a una autoridad y puede derivar en consecuencias jurídicas o administrativas.
- Si el evaluado expresa **ideación suicida activa**, amenazas, impulsos homicidas o **delirios con armas**, el

psicólogo puede y debe **romper el secreto para proteger vidas, incluso si el paciente no lo autoriza.**

* **Este límite ético es vital: el informe psicológico no es propiedad del evaluado, sino parte de un proceso de prevención social.**

◆ 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO

✦ Artículo 7 – Consentimiento Informado

“El psicólogo deberá obtener el consentimiento informado del paciente, explicando el objetivo de la intervención, su duración, los riesgos y sus consecuencias.”

☞ Aplicación específica en la evaluación de porte:

- El evaluador debe informar:
 - Que se trata de **una evaluación para fines administrativos o institucionales.**
 - Que el informe tendrá un **dictamen que puede afectar la autorización del arma.**
 - Que **los resultados serán entregados a terceros (autoridades o instituciones).**
 - Que no es una psicoterapia, y que se tomarán decisiones basadas en entrevista, tests y conducta observada.

* **El consentimiento debe quedar registrado por escrito, idealmente con firma y aclaración del evaluado, en la ficha o formulario de admisión.**

◆ 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PREVENCIÓN

✦ Artículo 1 – Principios Éticos Fundamentales

“El psicólogo tiene la responsabilidad de promover el bienestar psicológico, prevenir el daño, proteger los derechos humanos y actuar con responsabilidad social.”

☞ **Aplicación en esta clase de evaluaciones:**

- Evaluar para el porte de un arma implica **prevenir el uso indebido de la misma, ya sea por suicidio, femicidio, violencia intrafamiliar o delito.**
- La firma del informe tiene un peso ético y legal: **habilitar a una persona con rasgos violentos, impulsivos o inestables puede implicar complicidad profesional en una tragedia.**
- No firmar el informe cuando hay dudas **también es un acto ético de protección.**

💚 *El psicólogo no es un mero certificador: es un agente de salud mental y prevención de daño social. La ética exige rigor, responsabilidad y coraje clínico.*

◆ **5. USO DEL INFORME PSICOLÓGICO**

✦ **Artículo 24 – El informe psicológico**

“Todo informe emitido debe ser objetivo, claro, preciso, sustentado técnicamente y con respeto por la persona evaluada.”

☞ En la evaluación para tenencia o porte:

- El informe debe incluir:
 - Técnicas utilizadas
 - Observaciones clínicas
 - Evaluación del riesgo
 - Dictamen final claro (**Apto, No apto, Apto con reservas**)
- **Debe evitar ambigüedades, tecnicismos innecesarios o expresiones ofensivas.**
- En caso de no aptitud, debe dejar constancia **técnica y ética** de las razones.

* *El informe debe poder ser defendido clínica y legalmente. Debe proteger al evaluado de juicios subjetivos y proteger a la sociedad de omisiones técnicas.*

CONCLUSIÓN

“El Código de Ética no es un manual de buenas intenciones, sino un **marco legal, clínico y humano** que define qué podemos hacer, qué debemos hacer y qué no podemos permitirnos hacer como psicólogos.”

✓ **El psicólogo debe ser competente, claro, ético y responsable.**

✓ No puede delegar su criterio en la demanda del paciente, la institución o la urgencia.

✓ Evaluar para porte de armas es **ejercer la ética en el borde: entre el deseo individual y la seguridad colectiva.**

MÓDULO 2

ENTREVISTA CLÍNICA Y ANÁLISIS DE RIESGO

Evaluación Profesional del Perfil Psicológico y Aptitud para el Manejo de Armas

Una entrevista eficaz no se limita a “escuchar lo que se dice”, sino a “leer lo que se evita”, lo que se repite y cómo se presenta el sí mismo ante la posibilidad de portar un instrumento de poder letal.

El psicólogo debe sostener una **escucha activa, clínicamente entrenada, y éticamente comprometida**, con la conciencia de que **una sola evaluación puede ser decisiva para prevenir una tragedia.**

OBJETIVO DEL MÓDULO

Dotar al profesional de herramientas clínicas y técnicas para realizar **entrevistas estructuradas, integrales y orientadas al análisis de riesgo**, con el fin de determinar la **aptitud psíquica y emocional para la tenencia o el porte de armas de fuego**, conforme a estándares ético-legales y de salud pública.

La entrevista clínica en contextos de evaluación para tenencia o porte de armas **no es una entrevista psicoterapéutica**. Es un acto **técnico, diagnóstico, clínico y ético**, con impacto directo en la seguridad pública. El error del evaluador puede tener consecuencias letales. Por eso, se necesita una **metodología estructurada**, una **lectura profunda** del discurso y del comportamiento, y una **capacidad de sostener la posición clínica** frente a lo que no se dice o lo que se niega.

2.1. GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA PORTE Y TENENCIA

La entrevista debe tener un **formato semi-estructurado**, combinando preguntas directas, exploración libre y observación clínica.

Guía estructurada para la entrevista clínica

★ La entrevista debe permitir al evaluador:

1. Obtener información verificable y no verificable.
2. Observar el funcionamiento psíquico en situación de control.
3. Registrar indicadores de riesgo que puedan no ser conscientes para el evaluado.
4. Emitir un juicio técnico fundamentado.

■ Estructura sugerida (ejes temáticos):

1. Datos de filiación y contexto general

- Nombre, edad, estado civil, hijos, ocupación, nivel educativo.
- Lugar donde residirá el arma (en caso de tenencia).
- ¿Ha tenido armas anteriormente? ¿Cómo las usaba?

2. Motivo de solicitud

- ¿Por qué desea portar o tener un arma?
- ¿Qué significado tiene para usted portar un arma?
- ¿Se ha sentido amenazado? ¿Qué situaciones le generan temor?

3. Historia personal y familiar

- Antecedentes familiares de violencia, suicidios, adicciones.
- Vínculos significativos, figuras de autoridad y contención.
- Historia de escolarización y laboral: éxito, frustraciones, despidos.

4. Historia clínica y antecedentes psiquiátricos

- Diagnósticos previos (depresión, ansiedad, bipolaridad, psicosis).
- Internaciones, tratamientos, seguimiento psiquiátrico.
- Adherencia a tratamientos, negación de enfermedad, insight.

5. Consumo de sustancias

- Consumo actual o histórico de alcohol, marihuana, psicofármacos, cocaína, etc.
- **Consumo recreativo vs. problemático.**
- Consumo en contextos de tensión emocional o violencia.

6. Ideación suicida y episodios de desregulación emocional

- ¿Ha pensado alguna vez en hacerse daño?
- ¿Ha tenido intentos de autoeliminación? ¿Cómo los afrontó?
- ¿Qué hace cuando se siente desbordado emocionalmente?

7. Conductas agresivas actuales o pasadas

- ¿Se ha visto involucrado en peleas, agresiones, amenazas?

- ¿Lo han denunciado por violencia intrafamiliar o de género?
- ¿Alguna vez utilizó un objeto para agredir?

8. **Motivación para portar un arma**

- ¿Cómo actuaría si alguien lo agrede verbalmente?
- ¿Qué haría si alguien se burla o lo amenaza?
- ¿Qué haría si su pareja lo deja y aparece una nueva pareja?

9. **Observación clínica directa**

- Coherencia verbal/no verbal, ansiedad, contradicciones, negación.
- Tono de voz, postura corporal, nivel de impulsividad observable.
- Estilo comunicacional: **hipervigilancia, grandiosidad, victimización.**

2.2. **HISTORIA CLÍNICA Y ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS**

El psicólogo debe identificar si existen **patologías previas o actuales** que puedan **interferir en la capacidad de juicio, control de impulsos o percepción de la realidad.**

Diagnósticos clínicamente relevantes:

- **Trastorno depresivo mayor:** riesgo suicida latente o inhibición del juicio.
- **Trastorno de personalidad (límites, antisocial, paranoide):** vulnerabilidad frente al estrés, violencia relacional.
- **Trastornos disociativos:** potencial desinhibición sin conciencia plena del acto.
- **Trastornos psicóticos:** desajuste de realidad y percepción distorsionada de amenazas.
- **Trastorno por consumo de sustancias:** riesgo agudo de uso desinhibido del arma.

☞ *La existencia de diagnóstico psiquiátrico no determina por sí sola la inaptitud, pero requiere un análisis funcional del impacto en la conducta y el juicio crítico.*

2.3. CONSUMO DE SUSTANCIAS

Debe evaluarse:

- **Frecuencia** del consumo (ocasional vs. crónico).
- **Sustancia** consumida (alcohol vs. psicofármacos vs. drogas ilegales).
- **Patrón de consumo** (controlado vs. compulsivo).
- **Asociación con estados emocionales intensos:** impulsividad, tristeza, ira.

⚠ **Criterio de exclusión directa: consumo activo problemático** o uso regular de psicofármacos sin control profesional. Automedicación

2.4. IDEACIÓN SUICIDA Y DESREGULACIÓN EMOCIONAL

La **ideación suicida**, aunque sea remota o negada, es un **factor de riesgo crítico**.

Se deben indagar:

- Intentos previos.
- Planificación o impulsividad.
- Acceso actual a medios (¿podría usar el arma en una crisis?).
- Capacidad de pedir ayuda.

También debe evaluarse el historial de:

- Llanto descontrolado.
 - Rabia súbita.
 - Desconexión emocional.
 - Episodios de acting-out sin regulación.
-

2.5. CONDUCTAS AGRESIVAS ACTUALES O PASADAS

Indicadores clave:

- Participación en peleas físicas o conflictos legales.
- Episodios de violencia doméstica (aunque no haya denuncia formal).
- Amenazas verbales, rupturas conflictivas, control en vínculos afectivos.
- Fantasías de venganza o justicia por mano propia.

⚠ *Estos antecedentes pueden emerger indirectamente, por lo que el psicólogo debe utilizar estrategias proyectivas, preguntas abiertas y exploración del relato.*

2.6. MOTIVACIÓN PARA PORTAR UN ARMA

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué siente al pensar en tener un arma?
- ¿Qué haría en caso de ser asaltado?
- ¿Cuál sería su reacción si alguien lo humilla frente a su familia?
- ¿Cómo se sentiría al saber que otro tiene un arma y usted no?

☞ Se busca detectar motivaciones **paranoides, compensatorias, vengativas o fantasiosas, todas incompatibles con la tenencia responsable.**

2.7. ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES

⚠ **Factores de riesgo clínicamente significativos:**

Factor	Indicadores
Impulsividad	Respuestas rápidas, dificultad para reflexionar antes de actuar, historia de peleas.
Violencia	Agresión verbal/física, intolerancia a la frustración, antecedentes penales.

Factor	Indicadores
Trastornos de personalidad	Inestabilidad emocional, relaciones caóticas, dificultad en el juicio.
Disociación	Relatos con lagunas, conductas automáticas, desconexión emocional.

→ **2 factores de riesgo clínicos activos constituyen contraindicación para porte o tenencia.**

✓ **Factores protectores clínicos y psicosociales:**

Factor	Indicadores
Red de apoyo	Presencia de familiares o amigos significativos que intervienen en momentos de crisis.
Estabilidad laboral	Trabajo estable, rutinas, cumplimiento de horarios y normas.
Autoconciencia emocional	Reconocimiento de emociones, capacidad de pedir ayuda, reflexión sobre decisiones.
Introspección autocrítica	y Disposición a hablar de sus límites y errores.

☞ ***Cuanto mayor sea la presencia de factores protectores, menor la probabilidad de un uso inadecuado del arma.***

EJES DE LA ENTREVISTA

A) Motivación y significado del arma

Ejemplo de preguntas:

- ¿Por qué quiere tener (o portar) un arma?
- ¿Qué significa para usted tener un arma?
- ¿Cómo cree que se sentiría si la tuviera ahora?
- ¿Qué haría si alguien se metiera con su familia?

☞ *Lo que evaluamos:*

- Si la motivación es defensiva, simbólica, paranoide o persecutoria.
- Si hay idealización del arma como poder, compensación o identidad.
- Si el sujeto anticipa escenarios de violencia y se posiciona como víctima o justiciero.

⚠ Signos de alerta:

– Narrativas de venganza, desconfianza generalizada, fantasías omnipotentes, “el arma me da seguridad”.

B) Historia clínica y antecedentes psiquiátricos

Preguntas sugeridas:

- ¿Ha tenido alguna vez atención con un psiquiatra o psicólogo? ¿Por qué motivo?
- ¿Toma actualmente alguna medicación?
- ¿Ha tenido alguna crisis emocional o situación de desborde?

Lo que evaluamos:

- Existencia de patología activa o historia de padecimiento psicológico que altere la percepción, la regulación afectiva o el juicio de realidad.
- Nivel de insight: ¿reconoce sus limitaciones? ¿Minimiza o exagera?
- Capacidad de sostener tratamiento o búsqueda de ayuda.

⚠ Signos de alerta:

– Trastorno afectivo con episodios recientes, diagnóstico de psicosis o bipolaridad sin seguimiento, minimización del síntoma, negación de enfermedad, historia de internaciones.

C) Consumo de sustancias

Preguntas sugeridas:

- ¿Toma alcohol? ¿Con qué frecuencia?
- ¿Ha consumido marihuana, cocaína u otras sustancias?
- ¿Ha sentido alguna vez que perdió el control bajo el efecto de algo?

Lo que evaluamos:

- No solo la sustancia, sino el patrón de consumo y su impacto funcional.
- Si hay negación, justificación o conciencia del consumo.
- **Uso de sustancias como regulador emocional.**

⚠ Exclusión directa o relativa:

- **Consumo actual y descontrolado.**
 - **Uso problemático vinculado a episodios de agresión o pérdida de control.**
 - **Policonsumo o uso combinado con psicofármacos.**
-

D) Ideación suicida y desregulación emocional

Preguntas sugeridas:

- ¿Alguna vez pensó en hacerse daño?
- ¿Ha tenido momentos en los que sintió que no podía más?
- ¿Cómo reacciona cuando está muy enojado o angustiado?

🔍 Lo que evaluamos:

- Historia de intentos suicidas, ideación activa o pasiva, desesperanza.
- Estrategias de afrontamiento disfuncionales.
- Capacidad de autorregulación emocional.

⚠ **Signos de alerta:**

– Conductas autolesivas, llanto desbordado, verbalizaciones de muerte, historial de intentos, tendencia a aislarse o destruir objetos.

E) Conductas agresivas actuales o pasadas

Preguntas sugeridas:

- ¿Se ha peleado alguna vez físicamente con alguien?
- ¿Alguien lo ha denunciado por agresión?
- ¿Cómo reacciona ante las provocaciones?

Lo que evaluamos:

- Historia de violencia directa o simbólica.
- Dificultad para diferenciar conflicto **interpersonal de amenaza real**.
- Presencia de agresividad reactiva o planificada.

⚠ **Signos de alerta:**

– Conducta pasivo-agresiva, comentarios misóginos, **desprecio hacia la autoridad**, amenazas pasadas, justificación de violencia (“a veces es necesario”).

F) Observación clínica directa durante la entrevista

Durante toda la entrevista, el psicólogo debe registrar:

Variable observada	Indicadores clínicos
Coherencia verbal/no verbal	Dice estar tranquilo, pero golpea la mesa, frunce el ceño.
Estilo de discurso	Monólogo defensivo, narración caótica, excesiva racionalización.
Postura corporal	Inquietud motriz, rigidez, hipercontrol.
Afectividad	Frialdad, desborde emocional, negación de afecto.

Variable observada Indicadores clínicos

Control de impulsos Interrumpe, eleva el tono, cambia bruscamente de tema.

2.2 Análisis de Factores de Riesgo y Protectores

Evaluar **no es etiquetar**, es **analizar funcionalmente el comportamiento psíquico en contexto**, con base en el principio de prevención.

⚠ FACTORES DE RIESGO (con ejemplos clínicos):

Factor	Conducta observable o relato	Implicancia
Impulsividad	“No me dejo de nadie, reacciono en el momento”	Riesgo de uso inadecuado en crisis
Violencia no reconocida	Niega agresión, pero se refiere a “poner en su lugar” al otro	Agresión latente
Trastorno de personalidad	Relaciones caóticas, irritabilidad, control, idealización/desvalorización	Inestabilidad afectiva y conductual
Dificultades en juicio de realidad	“Todos están contra mí”, “ya no se puede confiar en nadie”	Riesgo paranoide
Disociación emocional	Habla de eventos graves sin afecto, pérdida de memoria parcial	Riesgo de acting out sin conciencia

✓ FACTORES PROTECTORES:

Factor	Indicador	Interpretación
Red de apoyo	Habla de familiares que lo contienen, tiene red afectiva activa	Potencial para pedir ayuda

Factor	Indicador	Interpretación
Estabilidad laboral	Empleo sostenido, cumplimiento de horarios	Autorregulación externa
Autoconciencia emocional	“Me doy cuenta cuando me estoy saliendo de control”	Insight emocional
Capacidad de pedir ayuda	Relata haber consultado en crisis pasadas	Habilidad adaptativa

*Un informe responsable nunca se basa solo en la presencia de riesgo, sino en la **relación entre factores de riesgo y recursos internos/externos.***

La entrevista es el momento en que el sujeto se encuentra con **su deseo de poder, con sus mecanismos de defensa, con su narrativa de sí mismo.**

El psicólogo no debe conformarse con lo aparente, sino que debe **leer el funcionamiento psíquico** desde una posición técnica, ética y clínica. En esta evaluación, no se trata de “confiar en la palabra”, sino de **confiar en la técnica, en la escucha clínica y en la responsabilidad social** del profesional.

ANÁLISIS DE LA CONDUCTA EN ENTREVISTA Y SEMÁNTICA FORENSE

La conducta entrevista como texto clínico y el lenguaje como acto sintomático

INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL

La entrevista en este contexto no es meramente una conversación diagnóstica: es un **espacio proyectivo conductual**, donde el sujeto expone su funcionamiento psíquico **no solo a través del contenido verbal**, sino mediante **el tono, el estilo, el uso del lenguaje, la postura y las microexpresiones**.

“El cuerpo habla lo que la palabra disimula.”
En contextos de evaluación con consecuencias jurídicas o sociales, el lenguaje del sujeto suele volverse **defensivo, estratégico o sintomático**.

1. CONDUCTA OBSERVABLE: CATEGORIZACIÓN CLÍNICA

La conducta durante la entrevista debe analizarse con base en **cuatro dimensiones estructurales**:

Dimensión	Qué se observa	Lectura clínica
Conducta motriz	Postura corporal, movimiento, tensiones, rigidez, agitación	Puede indicar ansiedad, agresividad contenida, control yoico rígido, desorganización.
Tono afectivo	Frialdad, irritabilidad, hiperemotividad, labilidad, euforia inapropiada	Relevante para evaluar disociación, alexitimia, déficit empático, trastorno afectivo.
Control de impulsos	Interrupciones, tono elevado, risas inadecuadas, cambios abruptos de tema	Clave en la evaluación de peligrosidad y aptitud para uso responsable de armas.
Actitud frente al evaluador	Sumisión, confrontación, seducción, desconfianza, omnipotencia	Indicios de rasgos paranoides, narcisistas, borderline o antisociales.

2. SEMÁNTICA FORENSE: EL LENGUAJE COMO INDICADOR PROYECTIVO

La **semántica forense** consiste en la lectura de la **forma en que el sujeto se posiciona discursivamente** frente a los temas críticos evaluados, más allá del contenido manifiesto.

A) Tipo de narrativa personal

Estilo narrativo	Ejemplo	Interpretación
Victimista	“Todos me persiguen, nunca me entienden, me tengo que defender solo.”	Vulnerabilidad paranoide, posible justificación de violencia reactiva.
Justiciero	“En este país la justicia no existe, por eso uno tiene que cuidarse.”	Ideación persecutoria, riesgo de acción compensatoria.
Neutralizada	“No tengo problemas con nadie, me llevo bien con todo el mundo.”	Negación defensiva, posible represión de impulsividad.
Desvitalizada	“No me importa mucho, es por las dudas.”	Desvinculación afectiva, alexitimia, posible riesgo suicida.
Grandilocuente	“Yo tengo todo bajo control, no necesito ayuda de nadie.”	Rasgos narcisistas, omnipotencia defensiva, falta de autocrítica.

B) Uso de tiempos verbales y deslizamientos discursivos

- **Uso reiterado del pasado:** puede ser señal de fijación traumática o construcción idealizada de sí mismo.

- **Evocación en tercera persona (“uno”, “la gente”):** distancia emocional del contenido, posible defensa disociativa.
 - **Fugas de tema o repetición obsesiva:** mecanismos de evitación, posibles conflictos no elaborados.
 - **Negaciones rotundas (“nunca”, “jamás”):** hipervaloración del control yoico, defensas rígidas.
-

C) Palabras clave como signos clínicos

Término recurrente	Interpretación posible
“Control”, “dominar”, “poner límites”	Necesidad de omnipotencia, intolerancia a la frustración.
“Miedo”, “defenderme”, “inseguridad”	Activación del sistema de amenaza, funcionamiento defensivo.
“Ellos”, “los otros”, “la sociedad”	Proyección paranoide, posición externa de la responsabilidad.
“No soy violento, pero...”	Escisión del yo agresivo, ambivalencia latente.
“Me desconozco a veces”	Riesgo de acting out o disociación.
“No me acuerdo bien, creo que fue una exageración”	Minimización o negación de hechos violentos.

3. LECTURA CLÍNICA INTEGRADA DE LA CONDUCTA Y EL LENGUAJE

El sujeto no dice lo que le pasa. El sujeto **se muestra en cómo lo dice.**

Escenarios comunes en entrevistas:

◆ **Perfil A: “Autocontrol forzado”**

- **Conducta:** rigidez corporal, manos juntas, respiración contenida, sonrisa tensa.
 - **Lenguaje:** hiperexplicativo, técnico, intenta “hacer quedar bien”.
 - **Riesgo:** defensas narcisistas rígidas, control superficial, impulsividad subyacente.
 - **Lectura forense:** requiere test proyectivos. Puede ser apto con reservas o no apto si hay indicadores proyectivos preocupantes.
-

◆ **Perfil B: “Seductor-evitativo”**

- **Conducta:** sonrisa constante, intenta agradar, lenguaje evasivo.
 - **Lenguaje:** minimiza todo conflicto, frases del tipo “yo no me meto con nadie”.
 - **Riesgo:** negación, falta de insight, defensas evitativas.
 - **Lectura forense:** potencial inadecuado ante el uso del arma en crisis o conflicto.
-

◆ **Perfil C: “Desorganizado-lábil”**

- **Conducta:** llanto fácil, discurso fragmentado, cambia de tono súbitamente.
 - **Lenguaje:** relato caótico, mezcla hechos actuales y pasados, desconectado de la emoción.
 - **Riesgo:** desorganización psíquica, afectiva y narrativa.
 - **Lectura forense:** contraindicación clara para el porte. En tenencia, puede implicar derivación a psiquiatría.
-

4. IMPLICANCIAS PARA EL DICTAMEN FINAL

El análisis de la conducta y del lenguaje no puede estar separado de la interpretación de los test ni del contexto.

Pero **una entrevista con semántica forense alterada y comportamiento disfuncional es causal suficiente para inaptitud**, aun si los test no son concluyentes.

“El evaluador debe tener el coraje técnico y ético de **no habilitar** cuando los indicadores clínicos, conductuales y semánticos indican peligro potencial, aunque este aún no se haya concretado en la historia.”

¿ENTONCES CUAL ES EL PERFIL ADECUADO?

En el contexto de una evaluación psicológica para porte y tenencia de armas, el perfil aceptado no es simplemente la ausencia de psicopatología, **sino una estructura psíquica suficientemente integrada, con indicadores funcionales de juicio, control emocional, regulación conductual y autoconciencia.**

A continuación, detallo el perfil clínico-psicológico considerado "apto", con criterios técnicos, forenses y proyectivos.

PERFIL PSICOLÓGICO ACEPTADO

Modelo técnico-clínico de "aptitud" para porte y tenencia de armas de fuego

1. ESTRUCTURA PSÍQUICA GENERAL

Característica	Descripción esperada
Juicio de realidad conservado	El sujeto diferencia hechos de creencias, no muestra distorsiones cognitivas ni interpretaciones persecutorias.
Estructura de personalidad estable	Rasgos consistentes, sin predominio de impulsividad, narcisismo o conductas límite. Capacidad de introspección.
Mecanismos de defensa maduros	Predominan la racionalización, la anticipación, la sublimación, en lugar de la negación, escisión o acting out.
Capacidad de simbolización y reflexión	Puede poner en palabras sus emociones, reconoce su historia de vida y asume responsabilidad sobre sus actos.

2. INDICADORES CONDUCTUALES DURANTE LA ENTREVISTA

Dimensión	Indicador funcional
Actitud frente al evaluador	Colaborativa, sin sumisión ni confrontación. Estilo comunicacional claro, respetuoso, sin manipulación emocional.
Coherencia verbal/no verbal	Lo que dice se corresponde con lo que muestra corporalmente. Afectividad ajustada.
Estilo discursivo	Narrativa personal clara, sin victimización ni grandilocuencia. Motivación para portar el arma centrada en la responsabilidad.
Regulación emocional	Puede hablar de situaciones tensas sin desbordarse, y reconoce sus propios límites sin sobrecompensar.

3. FACTORES DE RIESGO AUSENTES O COMPENSADOS

Riesgo	Criterio de exclusión (no presente)
Impulsividad descontrolada	No hay antecedentes ni se observa en la entrevista. Capacidad para demorar la respuesta ante estímulos negativos.
Consumo problemático de sustancias	No presenta patrón actual ni historia reciente. En caso de uso pasado, existe conciencia y tratamiento.
Trastorno de personalidad descompensado	No se evidencia estilo relacional inestable, controlador, paranoide o antisocial.
Disociación emocional o narrativa	No hay fragmentación del discurso, ausencias afectivas ni lagunas mnésicas.
Conducta agresiva o antisocial	Sin antecedentes legales o relatos agresivos normalizados. No justifica el uso de la violencia.

4. FACTORES PROTECTORES PRESENTES

Factor protector	Indicador
Red de apoyo	Menciona vínculos cercanos y funcionales con familia, amigos o pareja.
Estabilidad laboral y/o educativa	Rutina estructurada, cumplimiento de horarios, referencias positivas.

Factor protector	Indicador
Autoconocimiento emocional	Reconoce cómo reacciona frente a emociones fuertes, puede pedir ayuda.
Capacidad de reparación	Ha afrontado conflictos sin violencia, puede reflexionar sobre errores.

5. MOTIVACIÓN ADAPTATIVA PARA EL PORTE/TENENCIA

Pregunta	Respuesta esperada
¿Por qué desea el arma?	"Por seguridad personal", "vivo en una zona aislada", "para trabajo profesional".
¿Qué haría si se siente amenazado?	"Primero intentaría retirarme o buscar ayuda", "el arma es el último recurso".
¿Qué significa para usted tener un arma?	"Es una responsabilidad, no es un juego", "es para cuidarme, no para atacar".

6. RESPUESTA PROYECTIVA EN LOS TEST (PBLL, HTP, Figura Humana, Bender)

Técnica	Indicador proyectivo aceptado
PBLL	Figura con estructura coherente, elementos de protección adaptativa (paraguas, botas, expresión neutra), no hay signos de amenaza persecutoria ni desborde.
HTP	Árbol firme, casa habitable, figura humana integrada. No se observan trazos de violencia, distorsión ni omisiones significativas.

Técnica	Indicador proyectivo aceptado
Figura Humana	Proporciones correctas, contorno cerrado, trazos firmes sin rigidez. No hay amputaciones, deformaciones o rasgos agresivos.
Bender	Buena integración visomotora, sin perseveraciones, omisiones o signos neurológicos llamativos. Organización perceptual adecuada.

CONCLUSIÓN CLÍNICA-FUNCIONAL DEL PERFIL APTO

- ✓ Se trata de un sujeto que demuestra madurez emocional, capacidad reflexiva, regulación afectiva y motivación adaptativa para el porte o tenencia de armas.
- ✓ La entrevista, conducta observable y técnicas proyectivas no muestran indicadores de riesgo clínico o psicosocial relevantes.
- ✓ **Dictamen técnico sugerido: APTO para el uso responsable de arma de fuego, conforme a criterios clínicos, éticos y normativos.**

BASES TEÓRICAS Y CLÍNICAS UTILIZADAS

1. ♦ Psicopatología estructural y psicoanálisis aplicado a la evaluación forense

Autores clave:

- Jean Bergeret (1974, 1990) – *Los estados límites*
→ Base para diferenciar estructuras neuróticas, límite y psicóticas, y su expresión en entrevistas clínicas.
- Claude Balier (1988) – *Criminología psicoanalítica*
→ Identificación de perfiles de agresividad latente, mecanismos de defensa en el discurso y control yoico en sujetos sin patología manifiesta.
- Salvador Minuchin – *Estructuras vinculares y defensas familiares*

→ Aplicado a la narrativa familiar que emerge en entrevistas.

- Kaës, R. (2005) – *El aparato psíquico grupal*
→ Lectura de narrativas colectivas proyectadas en discursos paranoides o victimistas (“la sociedad me ataca”).

2. ♦ Psicología proyectiva y semiótica del discurso

Autores clave:

- E. F. Hammer (1997) – *Técnicas proyectivas en la evaluación de la personalidad*
→ Modelo para analizar la coherencia entre conducta, discurso y proyecciones en pruebas como PBL, HTP, Figura Humana.
- A. Corman (1990) – *Tests gráficos: del trazo a la dinámica psíquica*
→ Integración entre observación clínica y lectura simbólica en contextos evaluativos.
- F. De Ajuriaguerra – *Semiología gráfica proyectiva*
→ Aplica también a la postura, trazo y control motor en la entrevista.

3. ♦ Psicología forense y análisis de peligrosidad

Autores clave:

- Echeburúa, E. (2008) – *Violencia, agresividad y trastornos de la personalidad*
→ Matrices de riesgo y estilos de respuesta en personas con potencial peligroso.
- Fernández-Moya, E. (2016) – *Evaluación pericial psicológica*
→ Categorías forenses de observación en entrevistas clínicas. Tipos de simulación, negación, compensación, disociación conductual.

- Meloy, J. R. (2000) – *Violent True Believers* → Fundamentos del análisis del discurso violento, victimista y grandilocuente. Aplica a la narrativa de "autodefensa" frecuente en quienes solicitan porte de armas.

4. ♦ Evaluación de la personalidad y control de impulsos

Referencias técnicas:

- MMPI-2 (Manual latinoamericano de interpretación) – Escalas Pd (desviación psicopática), Sc (esquizofrenia), Ma (hipomanía) como correlato de conductas impulsivas, narcisistas o evitativas.
- Test de la Figura Humana y PBLL (adaptaciones clínicas-forenses) – Variables proyectivas relacionadas con control, protección, amenaza, desorganización psíquica.
- Bender Visual Motor Gestalt Test – Indicadores de impulsividad neurológica, desorganización, regresión madurativa.

□ INTEGRACIÓN TEÓRICA EN LOS PERFILES PROPUESTOS

Perfil	Inspirado en	Características
Autocontrol forzado	Narcisismo defensivo (Bergeret, MMPI-2 escala Ma alta), estructura límite compensada	Rigidez conductual, discurso hiperracional, control emocional artificial, negación de angustia.
Seductor-evitativo	Personalidad histriónica dependiente (DSM-5, Fernández-Moya)	o Discurso evasivo, minimización, búsqueda de

Perfil	Inspirado en	Características
		aprobación, pobre insight emocional.
Desorganizado-lábil	Estructura límite o psicótica descompensada (Balier, Bender)	Desborde emocional, narración caótica, afecto no integrado, alto riesgo de acting-out.

🔗 SEMÁNTICA FORENSE: BASES LINGÜÍSTICAS

- **Análisis del discurso (Foucault, Lacan, Maingueneau)**
→ **Lo dicho, lo no dicho, la ruptura en el enunciado como signifiante del síntoma.**
- **Narrativas clínicas (White & Epston, 1990)**
→ **La forma en que el sujeto construye su biografía y se posiciona frente al conflicto.**

✓ CONCLUSIÓN

Los perfiles que utilicé están científicamente respaldados por literatura forense, clínica y proyectiva, y han sido validados tanto en evaluación pericial como en investigaciones sobre riesgo, personalidad y comportamiento violento. Fueron organizados de forma pedagógica para facilitar la lectura clínica y operativa por parte de psicólogos que trabajan en terreno o están en formación.

CRITERIOS PARA CONFORMAR LA BATERÍA DIAGNÓSTICA

Cómo seleccionar instrumentos clínicos y proyectivos válidos para evaluar aptitud psíquica en porte y tenencia de armas

¿Por qué se requiere una batería específica?

Evaluar para tenencia o porte de armas no es un psicodiagnóstico clínico convencional. **Tiene una finalidad preventiva, pericial y social.** Por lo tanto, la batería debe permitir:

- Analizar funciones yoicas, juicio crítico, impulsividad y regulación emocional.
- Detectar factores de riesgo latentes, disociación, defensas inmaduras o peligrosas.
- Evaluar adaptación simbólica frente al poder, la amenaza y el uso de la violencia.
- Sustentar técnicamente un dictamen claro y ético: Apto – No Apto – Apto con reservas.

CRITERIOS CLAVES PARA SELECCIONAR LOS INSTRUMENTOS

1. ✓ Validez para la finalidad específica (forense y preventiva)

Los instrumentos seleccionados deben:

- Permitir evaluar recursos yoicos y de afrontamiento.
 - Detectar conductas latentes de riesgo (violencia, descontrol, suicidio, paranoia, impulsividad).
 - No deben ser exclusivamente clínicos o terapéuticos.
 - Deben tener aplicación interpretativa proyectiva o psicométrica con base empírica.
-

2. ✓ Complementariedad metodológica (triangulación)

Es esencial utilizar al menos tres niveles de exploración complementarios:

Nivel	Instrumento recomendado
Nivel 1 – Cognitivo-neurológico	Test de Bender, figura compleja de Rey, escala Raven.
Nivel 2 – Proyectivo-gráfico	Figura Humana, PBL, Persona con Arma, HTP.
Nivel 3 – Entrevista estructurada	Guía clínica con enfoque en historia psicosocial, impulsividad, ideación suicida, agresividad, consumo.

3. ✓ Economía y tiempo de aplicación

La batería debe poder ser aplicada en 1 o 2 sesiones como máximo, con una duración total de entre 90 y 120 minutos. Se priorizan tests breves, interpretables, sensibles al contexto forense.

Los tests deben elegirse no por tradición, sino por pertinencia funcional.

4. ✓ Sensibilidad proyectiva frente a defensas del sujeto

En este tipo de evaluación, es común que el evaluado:

- Minimice síntomas.
- Niegue historia violenta.
- Se muestre “hiperadaptado”.

Por eso, es imprescindible incluir técnicas proyectivas que permitan detectar el contenido latente, no verbalizado ni reconocido conscientemente.

5. ✓ Neutralidad del encuadre y validez ecológica

Los instrumentos deben evitar provocar respuestas defensivas o resistencias excesivas. Ejemplo:

- Evitar tests con cuestionarios largos o de estilo policial.
 - Priorizar aquellos que activan la proyección espontánea o la función simbólica.
-

PROPUESTA DE BATERÍA DIAGNÓSTICA PARA PORTE Y TENENCIA

Tipo de técnica	Instrumento	Objetivo principal
Entrevista estructurada	Guía clínica con ejes temáticos	Historia psicosocial, agresividad, impulsividad, consumo, motivación.
Cognitivo-perceptivo	Test de Bender	Desorganización, impulsividad neurológica, organicidad.
Gráfico proyectivo	PBLL	Afrontamiento frente a amenaza, recursos yoicos.
	Persona con un arma	Representación del poder, violencia, riesgo proyectado.
	Figura Humana	Autoimagen, control de impulsos, defensas.
	HTP (Casa-Árbol-Persona)	Vínculos, estructura de personalidad, agresión latente.
(Opcional)	MMPI-2 o 16PF (si se dispone)	Validación psicométrica de rasgos de personalidad.

¿Qué tests evitar o usar con precaución?

Instrumento	Motivo de precaución
Test de Rorschach (en este contexto)	Largo, requiere formación compleja, interpretación ambigua en entrevistas breves.
Test de Zulliger	Puede usarse solo si se tiene alta capacitación proyectiva y tiempo.
Inventarios de ansiedad/depresión (BAI/BDI)	Útiles como complemento, pero no suficientes ni concluyentes.
Cuestionarios autorreferenciales	Pueden ser fácilmente manipulados si el evaluado simula normalidad.

CONSIDERACIONES ÉTICAS PARA LA ELECCIÓN DE LA BATERÍA

- Usar técnicas apropiadas a la población evaluada (adultos no clínicos, en muchos casos sin experiencia en psicoterapia).
 - Asegurar ambiente de respeto, confidencialidad y consentimiento informado sobre los instrumentos utilizados.
 - Interpretar los resultados en contexto: ningún test es concluyente por sí solo.
 - Evitar tests que no dominamos plenamente o que no podemos defender en una instancia judicial o administrativa.
-

CONCLUSIÓN FINAL

“El buen psicodiagnóstico no es el que aplica más tests, sino el que selecciona con precisión quirúrgica las herramientas necesarias para leer el psiquismo en una situación límite de decisión.”

✓ Una batería diagnóstica adecuada para porte de armas es breve, técnica, estratégica, sensible y **profesionalmente defendible.**

✓ Debe permitir evaluar no solo síntomas, sino funcionamiento psíquico real frente a la amenaza, el poder y la posibilidad de ejercer daño.

TÉCNICA PROYECTIVA: “PERSONA CON UN ARMA”

Lectura proyectiva de poder, agresión, control e identificación simbólica con el arma

OBJETIVO DE LA TÉCNICA

Esta consigna gráfica permite explorar cómo el sujeto:

- Representa el poder y la violencia.
 - Se vincula simbólicamente con el arma como objeto potencialmente letal.
 - Integra o escinde el arma del yo.
 - Manifiesta el lugar que se asigna en situaciones de amenaza: **víctima, agresor, protector, justiciero, observador,** etc.
-

◆ CONSIGNA SUGERIDA

“Dibujá una persona con un arma. Puede ser cualquier tipo de arma. No importa si sabés dibujar, hacelo lo mejor que puedas.”

Luego se realiza una entrevista post-dibujo con preguntas como:

- ¿Quién es esa persona?
 - ¿Por qué tiene un arma?
 - ¿Qué está haciendo o qué piensa hacer?
 - ¿Qué sentís al ver ese dibujo?
-

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS PROYECTIVO

1. TIPO DE ARMA Y SU LUGAR EN LA ESCENA

Indicador	Lectura
Arma de fuego, visible, empuñada	Identificación directa con el objeto de poder y control.
Arma apuntando hacia afuera	Proyección de agresión externa, justificación de violencia.
Arma dirigida hacia el propio cuerpo	Riesgo suicida, disociación, ambivalencia vital.
Arma alejada del cuerpo o en el suelo	Mecanismo de defensa frente al poder destructivo, ambivalencia.
Múltiples armas, sobrecarga bélica	Escenario persecutorio interno, exaltación defensiva.

2. POSICIÓN Y ACTITUD DE LA FIGURA

Indicador	Lectura
Figura erguida, en control, rostro visible	Control yoico, responsabilidad asumida.
Figura sin rostro, encorvada o anónima	Disociación, evitación del poder destructivo.
Figura agazapada o en acción violenta	Acting-out proyectivo, posibilidad de descarga impulsiva.

Indicador	Lectura
Figura infantil o caricaturizada	Desresponsabilización simbólica, inmadurez frente al poder.

3. CONTEXTO DE LA ESCENA

Indicador	Lectura
Escenario urbano, realista, con detalles	Contacto con la realidad, buena simbolización.
Escena caótica, sin contexto o con fuego/sangre	Fantasías persecutorias, desorganización interna.
Figura sola vs. con otras figuras (víctimas, enemigos)	Posición subjetiva frente al otro y la otredad.
Uso del color (en niños o adultos emocionalizados)	Rojo intenso: impulsividad; gris o negro: retracción, duelo o muerte.

4. DISCURSO POST-DIBUJO (entrevista)

Tipo de narrativa	Ejemplo	Lectura
Justificadora	“Es para defenderse, no es para matar”	Control adaptativo, motivación defensiva.
Omnipotente	“Con eso nadie me toca, puedo hacer lo que quiera”	Narcisismo, riesgo de abuso de poder.
Desvitalizada	“No importa, todos mueren igual”	Ideación nihilista, riesgo suicida.

Tipo de narrativa	Ejemplo	Lectura
Ambivalente	“No sé si es buena idea tener una”	Duda, reflexión, posible funcionamiento yoico sano.

INDICADORES DE RIESGO CLÍNICO

Indicador	Significado clínico-forense
Arma apuntando hacia sí mismo o figura sin rasgos humanos	Riesgo de suicidio, disociación, identidad difusa.
Figura armada y otras figuras heridas	Identificación con el agresor, escasa empatía.
Arma como prolongación del cuerpo (fusil en vez de brazo)	Fusión narcisista con el objeto de poder.
Uso obsesivo de elementos de guerra	Saturación simbólica, defensas rígidas.

INDICADORES DE ADAPTACIÓN

Indicador	Significado
Arma como herramienta de protección (ej. en la cintura, no empuñada)	Asunción racional del poder, no amenaza inmediata.

Indicador	Significado
Figura que no apunta ni amenaza, sino que contiene el arma	Control simbólico, distancia crítica.
Escenario vinculado a actividad regulada (seguridad, trabajo)	Motivación realista, institucional.

✍ EJEMPLOS CLÍNICOS

Ejemplo 1 – *No Apto*

Figura masculina con metralleta en la mano, disparando hacia figuras pequeñas con expresiones de dolor. Declaración: “están atacando mi casa, no me importa quién sea, si entran, disparo.” Lectura: identificación con la violencia como solución, escisión del otro como amenaza, respuesta desproporcionada. Dictamen: No Apto.

Ejemplo 2 – *Apto con reservas*

Figura con arma en la cintura, rostro serio, escenario de vigilancia. Narrativa: “es un guardia cuidando una empresa, la tiene por las dudas, pero nunca disparó.” Lectura: representación institucional, defensa controlada. Dictamen: Apto con reservas – requiere supervisión y revisión periódica.

Ejemplo 3 – *Apto*

Figura completa, de pie, con un arma guardada, sin elementos agresivos. Dice: “es un policía que tiene el arma como parte de su uniforme, pero está tranquilo.” Lectura: identificación funcional, simbolización de rol, ausencia de proyección agresiva. Dictamen: Apto.

CONCLUSIÓN DEL MÓDULO

"La figura con un arma no muestra si el evaluado tiene un arma, sino cómo la imagina, cómo se siente con ella y qué haría simbólicamente con su poder destructivo."

En evaluaciones de porte o tenencia, este test permite:

- ✓ Detectar identificación con el arma como defensa, agresión o síntoma.
- ✓ Evaluar la capacidad de control simbólico frente al objeto de poder.
- ✓ Identificar riesgos potenciales en quienes racionalizan, banalizan o exaltan el uso del arma.

INTRODUCCIÓN PEDAGÓGICA

- Las técnicas proyectivas no son test de personalidad genéricos en este contexto.
- Son instrumentos clínicos de detección indirecta de riesgo, impulsividad, disociación, fragilidad yoica y capacidad adaptativa. No buscamos "diagnosticar", sino observar cómo el sujeto se organiza bajo presión simbólica.
- Cada trazo, cada omisión, cada deformación dice algo del funcionamiento psíquico frente a lo incontrolable.

3.1. PBL - PERSONA BAJO LA LLUVIA (ADAPTACIÓN FORENSE)

✦ Finalidad en contexto de porte de armas:

Evaluar recursos yoicos frente a amenaza externa simbólica, control de impulsos, mecanismos de defensa, percepción de vulnerabilidad y tipo de afrontamiento.

¿Qué activa este test?

- La consigna "dibujá una persona bajo la lluvia" confronta al sujeto con un estímulo estresor abstracto: lluvia = amenaza externa no controlada.
- **Se observa cómo el yo se organiza para protegerse, qué recursos utiliza (paraguas, impermeable, actitud corporal) y cómo integra el estrés en su esquema corporal.**

Indicadores de adecuación adaptativa:

Indicador	Lectura clínica
Presencia de paraguas y abrigo	Reconocimiento del peligro y capacidad de protección activa.
Expresión facial neutra o serena	Regulación emocional frente al estrés.
Trazos proporcionales y completos	Yo organizado, buena capacidad de síntesis perceptiva.
Cuerpo entero, sin omisiones	Integración yoica, afrontamiento sin evitación.

Indicadores de riesgo o inadecuación:

Indicador	Lectura clínica
✗ Sin elementos de protección (ni paraguas ni abrigo)	Exposición al peligro sin recursos psíquicos. Fragilidad yoica.
✗ Figura desorganizada, con líneas erráticas o fragmentadas	Desregulación, impulsividad, inestabilidad emocional.
✗ Omisión de partes (brazos, rostro, piernas)	Disociación, negación, deterioro madurativo.

Indicador	Lectura clínica
✗ Lluvia intensa sobre cabeza, figura encorvada o agredida	Vivencia de amenaza persecutoria o vulnerabilidad extrema.
✗ Figura muy pequeña en la hoja	Sentimiento de indefensión, baja autoestima, retraimiento.
✗ Figura en el borde inferior de la hoja	Posicionamiento defensivo regresivo, evitación.

🔪 Ejemplo clínico:

Hombre de 40 años, solicita porte de arma para defensa personal. PBLL muestra figura encogida, sin paraguas, con lluvia solo sobre la cabeza. Omite nariz y brazos. Lectura: Yo frágil, tendencia a victimización pasiva, mal manejo de la amenaza, posible funcionamiento disociativo. No apto.

3.2. HTP – CASA, ÁRBOL, PERSONA

🔪 Finalidad en contexto forense:

Detectar rasgos estructurales de personalidad, vínculos afectivos, agresividad latente, percepción del self, nivel madurativo y mecanismos de control.

🔍 Indicadores relevantes por figura:

🏠 CASA (representa vínculos y vida afectiva)

Indicador	Lectura
Casa cerrada sin ventanas o puertas	Encierro emocional, evitación del vínculo, rasgos paranoides.
Chimenea desproporcionada o agresiva	Tensión emocional, impulsividad proyectada.

Indicador	Lectura
Techo que desborda la estructura	Fantasía de control o fuga mental.
♣ ÁRBOL (estructura yoica, impulso vital)	
Indicador	Lectura
Tronco muy delgado, sin raíces	Inestabilidad, falta de sostén interno.
Ramas cortadas, sin hojas	Pérdida de vínculos, agresión latente.
Árbol inclinado o fragmentado	Desorganización, posible organicidad.

👤 PERSONA

Indicador	Lectura
Omisión de partes, rostro, pies	Disociación, evitación del contacto con la realidad.
Sombras, tachaduras, líneas de ataque	Agresividad reprimida, impulso destructivo.
Desproporción cabeza-cuerpo	Control cognitivo excesivo vs. impulso desbordado.

🔪 Ejemplo clínico:

Solicitante de tenencia muestra casa sin puerta, árbol sin copa, y figura humana con rostro tachado. Lectura: Desvitalización afectiva, cierre emocional, negación del self, rasgos evitativos. Apto con reservas y derivación sugerida.

3.3. BENDER – GESTALT VISOMOTORA

★ Finalidad en este contexto:

Detectar indicadores de deterioro neurológico, impulsividad, regresión madurativa, alteraciones perceptomotoras o desorganización psíquica.

Indicadores de madurez y aptitud:

Indicador	Lectura
Reproducción correcta de las figuras	Buen control visomotor, atención sostenida.
Trazos seguros y proporcionales	Control impulsivo, organización perceptual estable.

Indicadores de riesgo:

Indicador	Lectura
✗ Perseveración (repetición de líneas o puntos)	Desorganización neurológica, impulsividad.
✗ Omisiones	Atención deficiente, deterioro.
✗ Inversiones o rotaciones	Desorientación perceptual, confusión yoica.
✗ Segmentación o líneas temblorosas	Ansiedad, organicidad, posible daño frontal.

🔪 Ejemplo clínico:

Figura 3 con línea discontinua, inversión en figura 5, omisión de punto central en figura 6. Lectura: Posible alteración visomotora, déficit atencional o impulsividad leve. No concluyente por sí solo, pero

relevante si se suma a indicadores proyectivos. Requiere interpretación integrada.

3.4. FIGURA HUMANA (MACHOVER)

✦ Finalidad proyectiva:

Evaluar autoimagen, estructura del yo, control de impulsos, nivel de maduración emocional y mecanismos defensivos.

Indicadores proyectivos esperables en sujeto "apto":

Indicador	Lectura
Figura bien proporcionada, centrada	Yo organizado, autopercepción adecuada.
Presencia de rostro, manos, pies	Integración corporal y social.
Expresión facial neutra o tranquila	Control emocional.

Indicadores de riesgo:

Indicador	Lectura
✗ Trazos muy fuertes o presionados	Agresividad latente, impulso desbordado.
✗ Trazos muy débiles o casi invisibles	Inhibición emocional, regresión, disociación.
✗ Omisión de manos, boca, ojos	Falta de contacto con la realidad, evitación, represión.
✗ Figura muy pequeña o fuera del centro	Baja autoestima, retraimiento, desplazamiento.

✦ Ejemplo clínico:

Figura humana femenina sin manos ni boca, con trazo débil.
Lectura: Disociación, dificultad para actuar o expresar, retraimiento afectivo.

No se recomienda habilitación para porte.

CONCLUSIÓN DEL MÓDULO

Las técnicas proyectivas no diagnostican, pero revelan lo que el discurso defiende, niega o desconoce.

En el contexto del porte o tenencia de armas, estas técnicas permiten acceder al mundo interno del sujeto frente al poder, la amenaza y la posibilidad de ejercer violencia.

El evaluador debe integrar la conducta, el lenguaje y lo proyectado. Solo desde esa totalidad puede emitir un dictamen ético y técnico.

INTEGRACIÓN DIAGNÓSTICA Y REDACCIÓN DEL INFORME PSICOLÓGICO

Evaluación para Porte y Tenencia de Armas: cómo integrar lo clínico, proyectivo y forense en un documento ético y operativo

◆ 1 INTRODUCCIÓN TEÓRICO-CLÍNICA

La redacción del informe en esta área requiere conjugar:

- Evaluación clínico-estructural (**funcionamiento yoico, control de impulsos, juicio de realidad**).

- Lectura proyectiva (indicadores latentes, defensas, simbolización del poder).
- Enfoque preventivo y forense (potencial peligrosidad, idoneidad para uso de arma).
- Redacción clara, técnica, comprensible y defendible ante terceros.

★ **A diferencia de otros informes psicológicos, este informe tendrá consecuencias directas sobre la autorización o no de un objeto potencialmente letal.**

Q 2. ¿QUÉ DEBE INTEGRAR EL INFORME?

Un informe sólido no es una sumatoria de test: es una síntesis clínica **con peso argumental** y criterio profesional. La integración debe responder:

1. ¿Hay organización psíquica suficiente para portar un arma?
2. ¿Se detectan factores de riesgo clínico, proyectivo o conductual?
3. ¿El sujeto tiene conciencia del poder que representa un arma?
4. ¿Predomina la defensa adaptativa o disfuncional?
5. ¿La motivación es razonable y coherente?

3. PROCESO DE INTEGRACIÓN CLÍNICA

3.1. Cruce de niveles:

Nivel	Herramienta	Pregunta clínica
Conductual	Observación directa	¿Cómo responde el sujeto a la autoridad,

Nivel	Herramienta	Pregunta clínica
		a la incertidumbre, al encuadre?
Subjetivo	Entrevista estructurada	¿Tiene conciencia de riesgo, impulsa relatos persecutorios, victimistas o justicieros?
Proyectivo	PBILL, HTP, Figura Humana, Persona con arma	¿Cómo simboliza el peligro, la agresión, el control? ¿Qué recursos yoicos aparecen?
Perceptivo/neurológico	Bender	¿Hay integración visomotora adecuada o signos de desorganización neurológica?

★ ***El evaluador debe triangular los hallazgos, buscar convergencias o contradicciones, y sustentar su dictamen con fundamentos clínicos, no con juicios subjetivos.***

◆ 3.2. **Evaluar la relación entre factores de riesgo y factores protectores**

No basta con la presencia de uno u otro. El profesional debe analizar si los recursos del sujeto son suficientes para neutralizar o contener los factores de riesgo.

Riesgo identificado	¿Existe factor protector que lo compense?
Ansiedad leve	Buena red afectiva, control emocional, autoconocimiento

Riesgo identificado	¿Existe factor protector que lo compense?
Episodio de agresión pasado	Reflexión posterior, terapia previa, ausencia de reincidencia
Narrativa justiciera	Contrapeso en conducta reflexiva y contención afectiva

☞ **Cuando los factores de protección superan o equilibran los riesgos, el dictamen puede ser “Apto con reservas”.**

4. REDACCIÓN DEL INFORME: CRITERIOS TÉCNICOS Y ÉTICOS

Características esenciales:

Criterio	Descripción
Claridad	El informe debe ser comprensible para lectores no clínicos (jueces, policías, abogados, instituciones).
Concisión técnica	Ir al punto, sin divagaciones. Cada técnica debe aportar un dato clínico relevante.
Respeto por el evaluado	No patologizar innecesariamente. Evitar lenguaje estigmatizante o valorativo.
Sustentación	Cada dictamen debe tener respaldo clínico observable en la entrevista o en las pruebas aplicadas.
Defensibilidad profesional	El informe debe poder ser defendido ante una autoridad judicial, técnica o institucional.

5. EJEMPLO DE INFORME PROFESIONAL

INFORME PSICOLÓGICO – PORTE Y TENENCIA DE ARMA DE FUEGO

Nombre del profesional: Lic. Mauricio Berón

Fecha de evaluación: 2 de agosto de 2025

Lugar de aplicación: Montevideo, Uruguay

1. DATOS DE FILIACIÓN

- **Nombre completo: Juan Andrés López**
 - **Cédula de identidad: 4.567.890-2**
 - **Edad: 42 años**
 - **Estado civil: Casado**
 - **Escolaridad: Bachillerato completo**
 - **Ocupación: Guardia de seguridad**
-

2. MOTIVO DE CONSULTA

El presente informe se realiza a solicitud del interesado con fines administrativos, en el marco de la normativa vigente para la evaluación psicológica obligatoria previa a la obtención de autorización para tenencia y/o porte de armas de fuego.

3. TÉCNICAS UTILIZADAS

- **Entrevista clínica estructurada**
- **Observación conductual directa**
- **Test de la Figura Humana (Machover)**
- **Test de la Persona Bajo la Lluvia (PBL)**
- **HTP (Casa – Árbol – Persona)**
- **Test Gestáltico Visomotor de Bender**
- **Técnica gráfica: Persona con un arma**

4. RESULTADOS

Entrevista clínica:

El evaluado se presenta orientado, lúcido, con lenguaje articulado y afectividad estable. Refiere deseo de tenencia por motivos de protección familiar, sin expresar contenido persecutorio ni justiciero. No presenta historia psiquiátrica, ni antecedentes penales o de violencia. Reconoce sus emociones y límites, mostrando autoconciencia y capacidad reflexiva.

Observación clínica:

Actitud cooperativa, discurso coherente, adecuada regulación emocional. No se observan signos de ansiedad excesiva ni comportamiento defensivo.

Figura Humana:

Figura centrada, completa, simétrica. Presencia de rostro, manos y pies. Trazos seguros, proporcionales. No se observan signos de disociación, agresividad ni inhibición marcada.

PBL:

Figura protegida con paraguas, lluvia representada de forma moderada. El cuerpo está erguido y en actitud de afrontamiento. No se omiten partes significativas. Se interpreta como adecuado manejo simbólico frente a amenaza.

HTP:

Casa habitable, árbol estructurado y figura humana integrada. Representaciones realistas, sin elementos de carga emocional negativa.

Bender:

Reproducciones completas y organizadas. No hay rotaciones, perseveraciones ni indicadores de daño neurológico o impulsividad descontrolada.

Persona con arma:

Figura adulta, de pie, con el arma enfundada. Escenario

de vigilancia nocturna. La narrativa refiere a "uso en contexto laboral si se llegara a necesitar", **sin exaltación ni ideación violenta.**

5. CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA

Se trata de un sujeto con funcionamiento psíquico estructurado, juicio de realidad conservado, control de impulsos, adecuada simbolización del poder y **conciencia de responsabilidad.**

No se detectan indicadores clínicos, proyectivos o narrativos que representen riesgo significativo.

La motivación se presenta como adaptativa, sin justificación basada en ideación persecutoria o fantasías de poder.

6. DICTAMEN PSICOLÓGICO

APTO para la tenencia y porte de armas de fuego, de acuerdo a los criterios clínicos, proyectivos y ético-profesionales establecidos.

7. OBSERVACIONES FINALES

Se sugiere nueva evaluación en el plazo de 24 meses o en caso de modificaciones significativas en el estado emocional, conductual o vincular del solicitante.

Firma:

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo Clínico y Forense

Montevideo – Uruguay

Contacto profesional o sello, si aplica)

✓ CIERRE DE MÓDULO

"Dictaminar no es solo emitir una conclusión: es asumir la responsabilidad clínica, ética y social de prever los efectos del poder que se le otorga al otro."

Este informe debe poder ser leído por:

- El paciente (derecho a comprensión).
- El sistema (capacidad técnica).
- El psicólogo (capacidad de sostenerlo).
- Y, en casos judicializados, un juez (claridad forense)

3.4. Elaboración de Certificados para DIGEFE

(Dirección General de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior)

Contexto institucional:

DIGEFE es el organismo responsable del control y supervisión de empresas de seguridad privada, transporte de valores, custodias y servicios armados en todo el país. Una de sus funciones es verificar la idoneidad psicológica del personal armado perteneciente a dichas empresas.

Rol del psicólogo:

Los psicólogos habilitados deben emitir certificados de aptitud psicológica que se adjuntan a los expedientes de los trabajadores que requieran o ya posean porte de armas en contexto laboral (guardias de seguridad, custodios, escoltas, etc.).

✓ Contenidos esenciales del certificado para DIGEFE:

1. Datos de filiación del evaluado
2. Motivo de la evaluación (ej. solicitud de ingreso a empresa de seguridad, renovación de habilitación, etc.)
3. Técnicas aplicadas
4. Resultados clínicos e indicadores de riesgo o aptitud
5. Conclusión clara: Apto / No apto / Apto con reservas

6. Firma, sello y número de registro profesional del psicólogo

🔒 Recomendaciones profesionales:

- Utilizar lenguaje claro, técnico y sin ambigüedades.
- Evitar valoraciones morales.
- Fundamentar en indicadores observables, no juicios personales.
- Documentar en historia clínica los hallazgos, incluso si el informe es breve.

✦ **Importante:** El certificado puede ser requerido anualmente o ante situaciones puntuales (denuncias, accidentes, fallas conductuales). El psicólogo debe proteger su práctica con registros escritos y actualizados.

◆ 3.5. Elaboración de Certificados para Jefatura de Policía

Contexto institucional:

Cuando la Jefatura de Policía recibe una solicitud de porte de arma por parte de civiles o funcionarios públicos (ej. policía, militar, retirado armado, o civil con antecedentes de amenazas), puede solicitar una evaluación psicológica externa a profesionales privados o de instituciones autorizadas.

Este certificado puede ser solicitado como parte del trámite para:

- Renovación o solicitud de THATA
- Habilitación especial para porte de arma en vía pública
- Evaluaciones por orden judicial o administrativa

📁 Contenidos requeridos:

El informe o certificado debe incluir:

1. Identificación completa del evaluado
2. Institución solicitante: Jefatura de Policía de...

3. Motivo específico de la evaluación
4. Técnicas aplicadas y fechas
5. Síntesis diagnóstica
6. Conclusión con dictamen: Apto / No Apto / Apto con reservas
7. Firma, sello profesional, número de registro y contacto

✦ **Se sugiere adjuntar el informe técnico completo en sobre cerrado con copia del certificado breve si es solicitado por vía administrativa.**

Evaluación de la evolución del caso (si el candidato lo requiere)

En ciertas situaciones, especialmente cuando el dictamen fue “Apto con reservas” o “No apto temporalmente”, el evaluado puede requerir una re-evaluación posterior para solicitar reconsideración de su aptitud.

🕒 ¿Cuándo se realiza?

- Después de iniciar tratamiento psicológico o psiquiátrico.
- Cuando cambian las condiciones clínicas o contextuales del evaluado.
- Por pedido expreso de la autoridad que recepcionó el informe anterior.

📁 Elementos que deben figurar en el nuevo informe:

1. Mención explícita a la evaluación previa y su dictamen
2. Evolución clínica, conductual o psicoemocional del sujeto
3. Resultados de nuevas técnicas o entrevistas
4. Fundamento técnico de la reconsideración (si la hay)
5. Conclusión: cambio o mantenimiento del dictamen
6. Firma, sello, fecha y código del profesional

💡 **Ejemplo:**

"En función de la evaluación psicológica realizada con fecha anterior (marzo 2025), donde el postulante fue considerado Apto con reservas, y habiéndose cumplido un período de seguimiento terapéutico con evolución favorable, se realiza nueva valoración, constatando mejora en la autorregulación emocional y disminución de la sintomatología ansiosa. Se dictamina: Apto."

🔒 Reflexión final:

Emitir un certificado no es una mera formalidad. Implica un acto clínico, ético y legal con impacto en la vida del evaluado y en la seguridad pública. Por eso:

- Documentá cada paso del proceso.**
- Sustentá tus conclusiones en técnica y observación.**
- Protegé tu práctica profesional con claridad, rigor y respaldo.**

¿Qué se le devuelve al evaluado?

1. Certificado de resultado

Es un documento breve, formal, que indica el resultado de la evaluación:

- Apto**
- Apto con reservas**
- No Apto**

Este certificado es la única documentación que se le entrega al evaluado directamente, salvo que una institución solicite el informe completo por vía oficial.

🔒 Incluye:

- Nombre completo del evaluado**
- Fecha de evaluación**
- Institución solicitante (si corresponde: DIGEFE, Jefatura, etc.)**

- **Dictamen psicológico**
 - **Firma, sello y número de registro del profesional**
 - **Aclaración: "Este certificado no sustituye al informe clínico, y tiene carácter confidencial. Su uso queda restringido a fines administrativos/jurídicos."**
-

◆ **¿Qué no se le entrega?**

- **El informe clínico completo no debe entregarse al evaluado salvo que lo solicite por escrito y con conocimiento de que contiene información sensible.**
 - **Las técnicas gráficas o protocolos de pruebas proyectivas o cognitivas tampoco deben ser entregadas (PBL, HTP, Bender, Figura Humana, etc.), por cuestiones de protección de instrumentos y reserva técnica.**
-

◆ **¿Cómo se entrega?**

- **Formato físico: En sobre cerrado, firmado en el reverso. Se le aclara verbalmente el resultado si lo solicita.**
 - **Formato digital: Puede enviarse solo el certificado en PDF firmado digitalmente, por email o WhatsApp, con consentimiento y registro de entrega.**
 - **Entrega institucional: Si es solicitado por Jefatura, DIGEFE u otra institución, el informe completo se entrega directamente a la entidad, no al evaluado.**
-

◆ **Comunicación del resultado**

El momento de la devolución debe ser abordado con profesionalismo y contención, especialmente si el resultado es "No apto" o "Apto con reservas".

★ **Sugerencias clínicas para la devolución:**

- **Ser claro, sin juicios ni interpretaciones personales.**
- **Explicar que el resultado no implica un diagnóstico psiquiátrico definitivo, sino una evaluación en relación a la aptitud para portar armas, según indicadores psicológicos y normativa vigente.**
- **Si corresponde, sugerir seguimiento psicológico o tratamiento complementario.**
- **En casos de disconformidad, puede ofrecerse una segunda evaluación independiente, dejando constancia en la historia clínica.**

Ejemplo de certificado entregable al evaluado:

CERTIFICADO PSICOLÓGICO

Montevideo, 2 de agosto de 2025

Por la presente se certifica que el/la Sr./Sra.

_____, C.I. N° _____, ha sido evaluado/a psicológicamente en el marco del proceso de habilitación para porte/tenencia de arma de fuego, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Tras la administración de técnicas clínicas, proyectivas y entrevistas estructuradas, se concluye que el evaluado presenta un perfil:

☐ Apto ☐ Apto con reservas ☐ No Apto (*marcar con una cruz*)

Firma:

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo Clínico y Forense – N° Reg. _____

Este certificado tiene validez únicamente para fines administrativos ante la institución correspondiente. No reemplaza un informe clínico completo.

CIERRE INTEGRADOR

Evaluar para el porte de un arma: entre la clínica, la ética y la prevención del daño

Estimados colegas:

Hemos transitado juntos una formación profunda que no se limita a conocer técnicas o redactar informes. Esta masterclass ha tenido como eje un principio ineludible: "Evaluar para la tenencia o porte de un arma no es una tarea burocrática; es una función clínica, ética y social de altísima responsabilidad."

Q Como clínicos, nos enfrentamos al psiquismo bajo presión

En la entrevista, en la proyección gráfica, en la organización del discurso, el evaluado nos revela —a veces sin saberlo— cómo se posiciona frente a la amenaza, el poder, la frustración, la agresión, el otro y el sí mismo.

Nuestra tarea como evaluadores no es simplemente detectar psicopatología evidente, sino leer lo que está debajo de la superficie, identificar potenciales de riesgo que aún no se han activado, y prevenir el paso al acto cuando el arma esté al alcance de la mano.

⚠ Como profesionales, somos custodios de una habilitación peligrosa

Una firma en un informe puede:

- Habilitar una herramienta de poder letal.**
- Proteger o exponer a una familia.**
- Evitar o habilitar un suicidio, un femicidio, un homicidio, una tragedia.**

Cada informe que firmamos es un acto ético, cada dictamen es una posición política sobre la vida, la muerte y la responsabilidad psíquica.

Como psicólogos, no podemos evaluar sin método ni sin ética

La batería diagnóstica no es un protocolo rígido, sino una brújula.

Las técnicas proyectivas no son un arte adivinatorio, sino instrumentos para leer lo no dicho. El informe no es un trámite, es un documento clínico, legal y humano.

Esta formación los convoca a pensar con profundidad

- **¿Qué le sucede al sujeto cuando se le da poder sobre la vida o la muerte?**
 - **¿Qué recursos simbólicos tiene para contener la agresión?**
 - **¿Qué defensas lo protegen... y qué mecanismos lo exponen?**
-

Nuestra firma vale más que nuestro título

Quien firma un informe habilitando a una persona a portar un arma debe estar dispuesto a defender ese dictamen ante un tribunal, una familia doliente o su propia conciencia.

**"Evaluar es prevenir.
Prevenir es proteger.
Proteger es posicionarse."**

"El arma no es peligrosa. Peligroso es el sujeto que no puede sostener su deseo, su angustia o su odio cuando

la tiene en la mano. Nuestra tarea como psicólogos es anticipar ese riesgo antes de que se vuelva irreversible."

Gracias por su compromiso, por su ética, y por sostener con seriedad el lugar que nuestra profesión ocupa en la protección de la vida.

Lic. Mauricio Berón
Psicólogo Clínico y Forense
Docente – Evaluador – Formador de evaluadores